

Tumores benignos y malignos del ovario

1. Introducción y relevancia clínica

Las masas ováricas comprenden un **espectro amplio de patologías**, desde **quistes funcionales benignos** hasta **carcinomas ováricos malignos**.

Su diagnóstico y manejo oportuno es esencial, ya que el **cáncer de ovario** es el **tumor ginecológico más letal**, debido a su **diagnóstico tardío y escasos síntomas iniciales**.

Los tumores ováricos pueden ser:

- **Benignos:** frecuentes en mujeres jóvenes.
- **Malignos:** típicos en posmenopáusicas.

☐ En EUNACOM se evalúa:

- Diferencias entre quistes benignos y sospechosos de malignidad.
 - Criterios ecográficos de alarma.
 - Uso de CA-125 y algoritmo de riesgo maligno (RMI).
 - Conducta según edad, tamaño y características de la masa.
-

2. Fisiopatología y clasificación

Los tumores ováricos se clasifican según el **tejido de origen**:

Tipo histológico	Origen	Ejemplo	Frecuencia
Epiteliales	Superficie ovárica	Cistoadenoma seroso / mucinoso, carcinoma seroso	65–70%

Germinales	Células germinales	Teratoma maduro, disgerminoma	20–25%
Estroma gonadal / cordón sexual	Células de la granulosa, teca o Sertoli-Leydig	Tumor de la granulosa, tecoma	5–10%
Metastásicos	De otros órganos (mama, colon, estómago)	Tumor de Krukenberg	5–10%

□ Los **tumores epiteliales** son los más frecuentes y los responsables de la mayoría de los casos de **cáncer de ovario**.

3. Epidemiología

- Incidencia: 15–20 por 100.000 mujeres/año.
- Pico bimodal:
 - **Benignos:** 20–40 años.
 - **Malignos:** >50 años.
- En Chile, el **cáncer de ovario** representa aproximadamente el **5% de los cánceres femeninos** y es **GES desde 2013**.

4. Clínica

a.

Síntomas inespecíficos

- Distensión abdominal o sensación de masa.
- Dolor pélvico leve o intermitente.

- Trastornos menstruales.
- Urgencia urinaria o constipación (por compresión).

b.

Síntomas de alarma (sugestivos de malignidad)

- Aumento progresivo del volumen abdominal.
- Ascitis.
- Baja de peso inexplicable.
- Dolor pélvico persistente.
- Síntomas gastrointestinales nuevos en mujer posmenopáusica.

☐ La triada “**masa pélvica + ascitis + CA-125 elevado**” es muy sugerente de cáncer de ovario.

5. Examen físico

- Palpación de **masa anexial fija, irregular o bilateral**.
- **Distensión abdominal o ascitis**.
- **Nódulos en fondo de saco (Douglas)** en casos avanzados.
- En etapas iniciales, puede ser asintomático.

6. Diagnóstico diferencial

Patología	Diferencia clave
Quistes funcionales	Pequeños, uniloculares, regresan espontáneamente

Endometriomas	“Vidrio esmerilado” en ecografía, dismenorrea
EIP o absceso tubo-ovárico	Dolor agudo, fiebre, leucocitosis
Miomas subserosos	Masa sólida separada del ovario
Tumores metastásicos	Bilaterales, CA-125 muy elevado, antecedente de cáncer digestivo

7. Exámenes complementarios

a.

Ecografía transvaginal (de elección)

Evalúa morfología, tamaño y contenido.

Característica	Benigno	Sospechoso / maligno
Contorno	Regular	Irregular o lobulado
Pared	Fina	Gruesa, papilas
Contenido	Anecoico	Ecogenicidad mixta, sólida o con septos
Tabiques	Ausentes o finos	Gruesos, >3 mm

Nódulos	Ausentes	Presentes, vascularizados
---------	----------	---------------------------

Bilateralidad	Rara	Frecuente
---------------	------	-----------

Ascitis	Ausente	Presente
---------	---------	----------

☐ **Ecografía simple y transvaginal combinadas** aumentan la sensibilidad diagnóstica.

b.

Marcadores tumorales

Marcador	Tumor asociado	Comentario
CA-125	Tumores epiteliales serosos	Elevado en cáncer, endometriosis, EIP
AFP (alfa-fetoproteína)	Tumor del seno endodérmico, teratoma inmaduro	Niñas y adolescentes
β-hCG	Coriocarcinoma, disgerminoma mixto	Requiere test de embarazo
LDH	Disgerminoma	Complementario
Inhibina / Estradiol	Tumor de la granulosa	Puede causar metrorragia

☐ En **EUNACOM**, suelen pedir **conducta ante masa anexial + CA-125 elevado en mujer >50 años → derivar a ginecología oncológica.**

c.

Algoritmo de Riesgo de Malignidad (RMI o índice de Jacobs)

$$\text{RMI} = \text{U} \times \text{M} \times \text{CA-125}$$

Donde:

- **U:** puntuación ecográfica (0–3) → irregularidad, sólidos, bilaterales, ascitis.
- **M:** menopausia (1 = pre, 3 = post).
- **CA-125:** valor en UI/ml.

□ **RMI >200 = alto riesgo de malignidad → derivar a oncología.**

d.

TC o RM abdominopélvica

- Para etapificación y planificación quirúrgica.
-

8. Tumores benignos más frecuentes

Tipo	Características clínicas / ecográficas
Cistoadenoma seroso	Unilocular, delgado, claro; puede ser grande
Cistoadenoma mucinoso	Multilocular, contenido espeso, puede alcanzar >20 cm
Teratoma maduro (quiste dermoide)	Mujeres jóvenes, ecogenicidad mixta, calcificaciones (“diente”)
Fibroma ovárico	Masa sólida, asociado a ascitis y derrame pleural (síndrome de Meigs)

Tecoma / granulosa

Secreta estrógenos → metrorragia

- ☐ En general, los **tumores benignos son unilaterales, regulares y móviles.**
-

9. Tumores malignos del ovario

a.

Tumores epiteliales (80–90%)

- Carcinoma seroso, mucinoso, endometrioide, células claras.
- Frecuente en mujeres posmenopáusicas.
- Bilaterales en 2/3 de los casos.
- Diagnóstico tardío → pronóstico desfavorable.

b.

Tumores germinales (10–15%)

- Mujeres jóvenes.
- Crecen rápido; pueden producir AFP, β -hCG o LDH.
- Ejemplos: disgerminoma, tumor del seno endodérmico, coriocarcinoma.

c.

Tumores del estroma gonadal (5%)

- Secretan hormonas (estrógenos o andrógenos).
 - Ejemplo: tumor de la granulosa (produce metrorragia y endometrio proliferativo).
-

10. Conducta según edad y características

Grupo	Conducta
Premenopáusica, masa simple <6 cm, CA-125 normal	Observación + control ecográfico 6–8 semanas
Premenopáusica, masa compleja o persistente	Laparoscopia diagnóstica / terapéutica
Posmenopáusica, cualquier masa con CA-125 elevado o sospechosa	Derivar a ginecología oncológica
Niñas y adolescentes	Considerar tumor germinal → AFP, β-hCG, LDH

11. Tratamiento

a.

Tumores benignos

- Quistectomía laparoscópica conservando el ovario.
- Ooforectomía si masa grande, recidivante o torsionada.

b.

Tumores malignos (MINSAL / FIGO 2023)

Tratamiento quirúrgico primario:

- Laparotomía exploradora con:
 - Histerectomía total.
 - Salpingooforectomía bilateral.

- Omentectomía.
- Linfadenectomía selectiva.
- Biopsias múltiples para etapificación.

Etapas avanzadas:

- Cirugía citorreductora + quimioterapia adyuvante (carboplatino + paclitaxel).
- En casos inoperables: quimioterapia neoadyuvante.

12. Complicaciones

Complicación	Descripción
Torsión	Dolor agudo intenso; urgencia quirúrgica
Rotura	Hemoperitoneo, dolor súbito
Hemorragia intratumoral	Dolor y anemia
Malignización	<1% de tumores benignos
Ascitis / metástasis peritoneales	En cáncer avanzado

13. Pronóstico

Depende del tipo histológico y la etapa FIGO.

- **Etapas I:** 90% supervivencia a 5 años.

- **Etapas III–IV:** <30% supervivencia.

□ Diagnóstico precoz = curación posible; diagnóstico tardío = mal pronóstico.

14. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□

Perlas

1. Masa anexial benigna: **unilocular, pared fina, sin septos ni papilas.**
2. Sospecha de malignidad: **masa compleja, sólida, bilateral, ascitis, CA-125 elevado.**
3. **CA-125** se eleva también en endometriosis y EIP.
4. **RMI >200** = alto riesgo de malignidad → derivar a oncología.
5. En premenopáusicas, la mayoría de las masas son **benignas.**
6. En posmenopáusicas, **toda masa ovárica es sospechosa hasta demostrar lo contrario.**
7. **Síndrome de Meigs:** fibroma + ascitis + derrame pleural (resuelve al extirpar tumor).

□

Errores comunes

- No solicitar **β-hCG** en mujer joven (descartar tumor germinal).
 - No derivar masa compleja con CA-125 elevado.
 - Operar por laparoscopia masa sospechosa sin medidas oncológicas.
 - No distinguir tumor funcional de neoplásico.
 - Usar CA-125 como único criterio diagnóstico.
-

15. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Los **tumores ováricos** pueden ser **benignos o malignos**; los epiteliales son los más frecuentes.
2. **Ecografía transvaginal** es el principal método diagnóstico.
3. **Criterios de sospecha**: masa compleja, irregular, bilateral, ascitis, CA-125 elevado.
4. **RMI >200** → **derivar a oncología**.
5. **Premenopáusica**: la mayoría benignos → control ecográfico.
6. **Posmenopáusica**: cualquier masa sospechosa = estudio oncológico.
7. **Tratamiento quirúrgico** según tipo, tamaño, edad y deseo de fertilidad.